Reflectie coschap cardiologie: een patiënt met pijn op de borst

Coassistent: Sophie **Opleiding:** Master Geneeskunde, coschap cardiologie **Locatie:** Stadsziekenhuis Vechtzicht **Reflectiemodel:** Gibbs

1. Beschrijving

Op dinsdagavond 4 november had ik avonddienst met de arts-assistent cardiologie. Om 22:35 uur belde de verpleging over meneer De Groot (62 jaar, naam aangepast), die die middag was opgenomen voor analyse van hartritmestoornissen. Hij had sinds een kwartier drukkende pijn op de borst met uitstraling naar de linkerarm. De arts-assistent was bezig op de SEH en vroeg mij om alvast naar de patiënt te gaan.

Ik heb eerst een uitgebreide anamnese afgenomen: aard en duur van de pijn, uitstraling, eerdere klachten, risicofactoren (roken, hypertensie, familieanamnese), medicatie en allergieën. Daarna deed ik lichamelijk onderzoek, inclusief bloeddruk aan beide armen om een aortadissectie uit te sluiten (152/94 links, 148/92 rechts). Na ongeveer twintig minuten heb ik een ECG laten maken. Dat liet ST-elevaties zien in II, III en aVF. Ik heb de arts-assistent gebeld, die direct kwam en het cathlab inschakelde. Meneer De Groot bleek een inferieur myocardinfarct te hebben en is succesvol gedotterd.

2. Gevoelens

Ik voelde me trots dat de arts-assistent mij vertrouwde om alleen naar de patiënt te gaan. Tijdens de anamnese voelde ik me rustig en zeker. Toen ik het ECG zag, schrok ik, en voelde ik me ook even onzeker of ik het goed had geïnterpreteerd.

3. Evaluatie

Wat goed ging, was mijn grondigheid. Ik heb een volledige anamnese afgenomen en geen enkele differentiaaldiagnose over het hoofd gezien: acuut coronair syndroom, longembolie, aortadissectie, pneumothorax en pericarditis heb ik allemaal overwogen. Het bloeddrukverschil tussen de armen heb ik actief gemeten. De arts-assistent zei achteraf dat mijn overdracht “heel compleet” was.

Wat minder goed ging, was mijn zekerheid bij het beoordelen van het ECG.

4. Analyse

Volgens de literatuur is een systematische benadering van pijn op de borst essentieel om levensbedreigende oorzaken niet te missen. Dat heb ik gedaan. Mijn onzekerheid over het ECG komt doordat ik in mijn coschappen nog weinig ST-elevatie-infarcten heb gezien. Ik had het ECG direct moeten interpreteren in plaats van de arts-assistent te bellen.

5. Conclusie

Ik heb in deze situatie laten zien dat ik een patiënt met pijn op de borst grondig en systematisch kan beoordelen. Het enige verbeterpunt is mijn zelfvertrouwen bij het lezen van ECG’s.

6. Actieplan

Ik ga de komende weken elke dag vijf ECG’s oefenen met een online module. Volgende keer wil ik bij een duidelijk ST-elevatie-infarct zelf de diagnose stellen en het cathlab inschakelen, zodat er geen tijd verloren gaat met het bellen van de arts-assistent.